

Esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad de difícil diagnóstico. A propósito de dos casos

Marina Raventós Galcerán, María Antonia Ribas Batllori y Mais Khoulí

ABS Centre. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. España.

Cuestiones para recordar

- La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, con desenlace fatal, que afecta a neuronas motoras de la médula espinal, tronco cerebral y corteza motora.
- La esclerosis lateral amiotrófica es tan frecuente como la esclerosis múltiple y más que la distrofia muscular.
- Aproximadamente el 75% de los pacientes presentan inicialmente clínica limitada a extremidades, el 25% signos de compromiso bulbar y el 10% debutan con predominio de signos de neurona motora superior.
- El diagnóstico se sustenta en la clínica, la exploración neurológica detallada y el electromiograma.
- Actualmente, el tratamiento se basa fundamentalmente en la fisioterapia y la ventilación mecánica con presión positiva en la vía aérea.

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica • Neurona motora • Atención primaria.

Introducción y epidemiología

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, con desenlace fatal, que afecta a neuronas motoras de la médula espinal, tronco cerebral y corteza motora.

Afecta principalmente a adultos entre 40 y 70 años, aunque hay muchos casos descritos en pacientes más jóvenes. La proporción entre hombres y mujeres es de 1,3/1. La incidencia en la población española es de 2/100.000 y la prevalencia es de 1/10.000. Es tan frecuente como la esclerosis múltiple y más que la distrofia muscular. La mayoría de los pacientes con ELA fallecen por fallo respiratorio, generalmente entre 3 y 5 años desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, alrededor del 10% sobreviven 10 años o más.

La mayoría de los casos son de presentación esporádica. Hay una forma hereditaria que representa el 5-10% de los casos.

A continuación, presentamos dos casos de ELA con sintomatología inicial atípica que ocasionó dificultad para el diagnóstico en atención primaria.

Caso 1

Varón de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), depresión a largo plazo (DLP) y diabetes mellitus (DM). Consulta por clínica de astenia, anorexia, pérdida de peso y diarreas intermitentes sin productos patológicos. Exploraciones complementarias: analítica sin hallazgos, con marcadores tumorales negativos; radiografía de tórax: elevación de hemidiafragma derecho; colonoscopia (CLS): pólipo de 4 mm en colon ascendente, que se extrae. Anatomía patológica: adenoma tubular con displasia de bajo grado. Fibrogastroscoopia (FGC): hernia de hiato. Ecografía y tomografía computarizada (TAC) abdominal normales.

A los pocos meses, el paciente consulta de nuevo por ánimo decaído, pérdidas de memoria e insomnio de segunda

hora, se pautan antidepresivos con escasa respuesta, que se atribuye parcialmente a falta de cumplimiento, y se deriva al centro de salud mental y a neurología para valoración diagnóstica. Se orienta como depresión y MCI amnésico y es dado de alta con tratamiento antidepresivo.

El paciente se mantiene más o menos estable sin presentar en ningún momento mejoría franca.

Aproximadamente 18 meses después del inicio del proceso, la astenia, las diarreas sin productos patológicos y la pérdida de peso se hacen de nuevo más acusadas. Nuevas FGC y CLS normales. Posteriormente, se añade clínica de ortopnea y disnea de pequeños-medianos esfuerzos. Se realiza radiografía de tórax, sin cambios respecto a previas, y TAC torácico que muestra atelectasias en paciente no fumador.

Por la persistencia de clínica de diarrea y pérdida de peso de casi 2 años de evolución, con disnea progresiva el último mes, sin haber encontrado neoplasia ni otra causa de la sintomatología, se decide derivar el paciente a la unidad de diagnóstico rápido.

El paciente presenta empeoramiento de su disnea por lo que acude a urgencias hospitalarias desde donde ingresa en el servicio de neumología con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Durante el ingreso se objetivan fasciculaciones en extremidades, debilidad de la musculatura distal de predominio en extremidades superiores (EES) y menor intensidad en extremidades inferiores (EEI), bajo tono de la voz sin alteraciones de la deglución. El paciente es valorado por neurología, que realiza EMG compatible con enfermedad difusa de neuronas motoras inferiores y orienta el diagnóstico como ELA sin afectación bulbar en el momento del diagnóstico, asociado a síndrome demencial de probable tipo Alzheimer.

Se inicia soporte ventilatorio con presión positiva en la vía aérea y oxigenoterapia con mejoría considerable de la gasometría y del estado general.

A los 9 meses del diagnóstico el paciente presenta incontinencia urinaria, a los 15 meses dificultad para la deambulación con caídas de repetición, a los 18 meses alteración de la deglución que requiere alimentación con espesantes, con empeoramiento progresivo, siendo exitus a los 21 meses.

Caso 2

Varón de 76 años con antecedentes de diabetes mellitus en tratamiento con hipoglicemiantes orales y dieta, con cumplimiento muy irregular de los controles, ex fumador, con criterios clínicos de bronquitis crónica.

Acude a la consulta por cervicalgia y lumbalgia mecánica no irradiada y dolor en brazo izquierdo después de caída casual en domicilio. Radiología lumbar y cervical: muestran severos signos de artrosis, sin aplastamientos vertebrales ni lesiones óseas agudas; se pauta tratamiento antiinflamatorio. El paciente reconsulta por persistencia del dolor, pérdida de peso y mal estado general. En la analítica general destaca hemoglo-

bina glicosilada de 12% por lo que se orienta como dolor mecánico por policonusiones y pérdida de peso y deterioro del estado general por mal control diabético. Se pautan antiinflamatorios esteroideos (AINE) y se inicia insulinización.

En las siguientes visitas el paciente refiere empeoramiento progresivo del dolor lumbar irradiado a extremidades inferiores, dificultad para la deambulación, astenia, ánimo decaído y cambio de ritmo deposicional con rectorragias. Exploraciones complementarias: radiografía tórax: atelectasia basal izquierda y nódulo parahiliar izquierdo. CLS: incompleta por mala preparación.

Dado el empeoramiento rápidamente progresivo del paciente en los últimos 3 meses, y ante la sospecha de neoplasia pulmonar y/o digestiva, se decide derivar a unidad de diagnóstico rápido del hospital de referencia.

Antes de ser evaluado por dicha unidad, el paciente acude a urgencias hospitalarias por disnea, mal estado general y debilidad. Es ingresado en el servicio de neumología por insuficiencia respiratoria hipercápnica de origen no filiado. En el hospital se observan fasciculaciones a nivel tenar e hipotenar, muslos y brazos, por lo que se le practica EMG con resultado compatible con afectación difusa de neuronas motoras inferiores.

Con el diagnóstico de ELA se inicia ventilación mecánica y se da el alta a domicilio.

El paciente reingresa a la semana por dolor abdominal y síndrome tóxico, con mala adaptación a la ventilación mecánica. Se decide hacer estudio no invasivo con TAC abdominal que descarta neoformación. Dada la mala evolución de la insuficiencia respiratoria, con intolerancia a la VMNI, ingresa en la unidad de curas paliativas, siendo exitus al cabo de una semana. Ha pasado 1 mes desde el diagnóstico y 4 meses del inicio de la clínica.

Clínica

La ELA debuta con diferentes signos y síntomas según cual sea la afectación de la neurona motora superior (NMS) e inferior (NMI) en las diferentes regiones corporales (tabla 1).

Aproximadamente el 75% de los pacientes presentan inicialmente clínica limitada a extremidades, el 25% con signos de compromiso bulbar y el 10% con predominio de signos de NMS. Puede presentarse con afectación focal o multifocal con posterior progresión a otras regiones.

Con frecuencia, los miembros superiores están afectados más precozmente que los inferiores, con clínica de debilidad muscular distal y amiotrofia, a menudo asimétrica. Es característica la pérdida precoz de masa muscular en los interóseos, que posteriormente se extiende a los extensores de antebrazo y a zonas más proximales, acompañándose de calambres y fasciculaciones. Cuando se comprometen los miembros inferiores, generalmente primero se afectan cuádriceps y los músculos de cara antero-externa de las piernas.

TABLA 1. Signos y síntomas de esclerosis lateral amiotrófica

Neurona motora afectada	Signos y síntomas
Médula espinal (NMI)	Debilidad muscular segmentaria Atrofia muscular Hiporreflexia Fasciculaciones Calambres musculares
Bulbo (NMI)	Disartria Disfagia Hipofonía Fasciculaciones en la lengua
Corteza motora (NMS)	Hiperreflexia Clonus Espasticidad Babinski Hoffman Debilidad muscular segmentaria Síntomas pseudobulbares
NMI: neurona motora inferior; NMS: neurona motora superior.	

Con el compromiso de NMS aparece hiperreflexia, clonus, reflejo cutáneo plantar extensor y espasticidad, que a menudo es lo que acaba limitando más al paciente.

El compromiso bulbar afecta inicialmente a los músculos de la lengua y el velo del paladar y se manifiesta como parésia progresiva de la deglución, disartria e hipofonía.

Las manifestaciones pseudobulbares se producen por compromiso córtico-bulbar bilateral e incluyen la risa y llanto espasmódico, trastornos práxicos deglutorios y disartria.

No existe compromiso de esfínteres ni de la musculatura ocular extrínseca hasta estadios avanzados, y las funciones autonómicas suelen mantenerse intactas aun en fases finales de la enfermedad.

La evolución de la enfermedad es irreversible, llevando al paciente a la inmovilidad casi completa, con severos trastornos deglutorios e insuficiencia respiratoria por compromiso de los músculos intercostales y del diafragma.

Diagnóstico

El diagnóstico de la ELA es clínico. Se basa en los criterios diagnósticos de El Escorial que permiten definir la enfermedad y establecer niveles de certeza diagnóstica.

El diagnóstico se sustenta en la clínica, la exploración neurológica detallada y el EMG.

Aun así, el diagnóstico es difícil y el tiempo promedio transcurrido entre los primeros síntomas y la confirmación diagnóstica es de unos 16 meses.

El EMG es especialmente útil para objetivar compromiso de músculos que no parecen afectados clínicamente. La evidencia electromiográfica de compromiso de NMI en, al menos, dos músculos inervados por diferentes raíces espinales o diferentes nervios periféricos o craneales en dos o más de las cuatro regiones (bulbar, cervical, torácica y lumbosacra) permite confirmar el diagnóstico de ELA.

Los estudios de neuroimagen (TAC, RM) pueden ser necesarios para descartar otras patologías, así como la biopsia de músculo y nervio.

Tratamiento

No existe tratamiento etiológico de eficacia probada. Están en estudio tratamientos como el riluzole, gabapentina y lamotrigina, mementine y dextrometorfan. El riluzole es por el momento el único fármaco aprobado para el tratamiento de la ELA.

Actualmente, el tratamiento se basa fundamentalmente en fisioterapia, ventilación mecánica con presión positiva en la vía aérea y control de la sintomatología conforme va presentándose, cuidados del paciente y soporte familiar.

Conclusión

Los dos casos presentados aquí coinciden en un inicio solapado, importante pérdida de peso y malestar general, con clínica digestiva sugestiva de neoplasia intestinal como primera opción diagnóstica. Según la bibliografía consultada, la clínica intestinal no es un debut habitual en la ELA.

La edad avanzada de ambos casos (70 y 76 años, respectivamente), la presencia de enfermedades concomitantes y las dificultades de comunicación que ambos presentaban en relación con un bajo nivel cultural, añaden dificultad al diagnóstico.

La pérdida de fuerza y la debilidad progresiva quedaron enmascaradas por el deterioro progresivo del estado general con importante pérdida de peso que en los dos casos se atribuyó a neoplasia oculta.

Puesto que la clínica no era sugestiva de enfermedad neuromotora no se realizó en ningún momento la búsqueda activa de fasciculaciones en la consulta de atención primaria ya que, dado el escaso tiempo de que se dispone por visita, excepto en casos de sospecha clínica, no es habitual realizar una exploración neurológica completa en nuestras consultas.

El diagnóstico de ELA se realizó en ambos casos cuando la afectación respiratoria fue evidente y obligó al ingreso hospitalario.

El diagnóstico de enfermedades neurológicas poco frecuentes y con síntomas iniciales inespecíficos es siempre difícil en atención primaria, sin embargo, es conveniente tenerlas presentes en el diagnóstico diferencial cuando nos encontramos, como en estos dos casos, con una enfermedad progresiva que afecta de forma importante a la calidad de vida del paciente, y en la que resultan negativas las exploraciones complementarias más habituales.

Bibliografía general

Asociación Española de ELA. Disponible en: <http://www.adelaweb.com/content/blogsection/7/80>

- Braunwald, E. Harrison. Principios de Medicina Interna. 15.^a ed. Madrid: Ed. McGraw-Hill; 2002.
- Brooks BR, Miller RG, Swash M, et al. El Escorial revisited: revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. *Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord*. 2000;1:293-9.
- Dubrovsky AL, Pirra L, Sica REP. Esclerosis lateral amiotrófica. *Revista Neurológica Argentina*. 2003;28:70-8.
- Farrero E, Prats E, Escarrabill J. Toma de decisiones en el manejo clínico de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. *Arch Bronconeumol*. 2003;39:226-32.
- Guía para la atención de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en España. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social; 2009. Disponible en: <http://www.msc.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/esclerosisLA.pdf>
- Torres L, Guevara EA, Mendoza G, Cosentino C. Características clínicas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. *Revista Diagnóstico (Perú)*. 2009;48:7-12.